

KC桌面——外资精译

波士顿咨询：印度制药创新从规模转向科学

印度制药业正经历一个关键转折。过去十年，超过10个原创药物资产从印度诞生——涵盖首创新化学实体、本土CAR-T疗法和AI发现分子。私募股权和不确定性研究在制药领域的投入五年间增长约2.1倍，到2026财年达到7.31亿美元；生物技术初创公司数量从约1500家增至约2400家，增长约1.6倍。专利提交量增长超过4倍，创新管线资产扩大约1.5倍。

这些数字背后是质的变化：印度公司正从仿制药和生物类似药转向原创、许可和全球竞争。但印度研发支出仍仅约20-30亿美元，仅为美国约700-750亿美元的零头。尽管承担全球约15%的疾病负担，印度仅开展约4%的全球临床试验。



图表 1

四大引擎正在搭建全栈创新体系

约50亿美元的政府资金正投向早期研究、人才和基础设施。学术界的角色也在强化：通过“印度创新”计划等大型项目推动产学合作，技术转移办公室网络正在将实验室成果推向市场。监管改革加速了审批流程——药物开发时间从180-270天缩短至60-120天，CDSCO约97%的业务已数字化，效率提升约25%。共享研发和制造基础设施也在建设中，包括三个原料药园区和生物制造产能。

早期实验室到市场的转化案例已经出现：ImmunoACT的NexCAR19——印度首个本土CAR-T疗法，价格比进口产品便宜约10倍；以及通过公私合作从CSIR基因组学与整合生物学研究所转移至印度血清研究所的CRISPR疗法BIRSA 101。

> KC评论：这些案例的意义不在于单个产品，而在于证明了印度从学术发现到商业化落地的完整链条可以跑通。对观察者而言，关键变量是这种模式能否从个例变成系统能力。

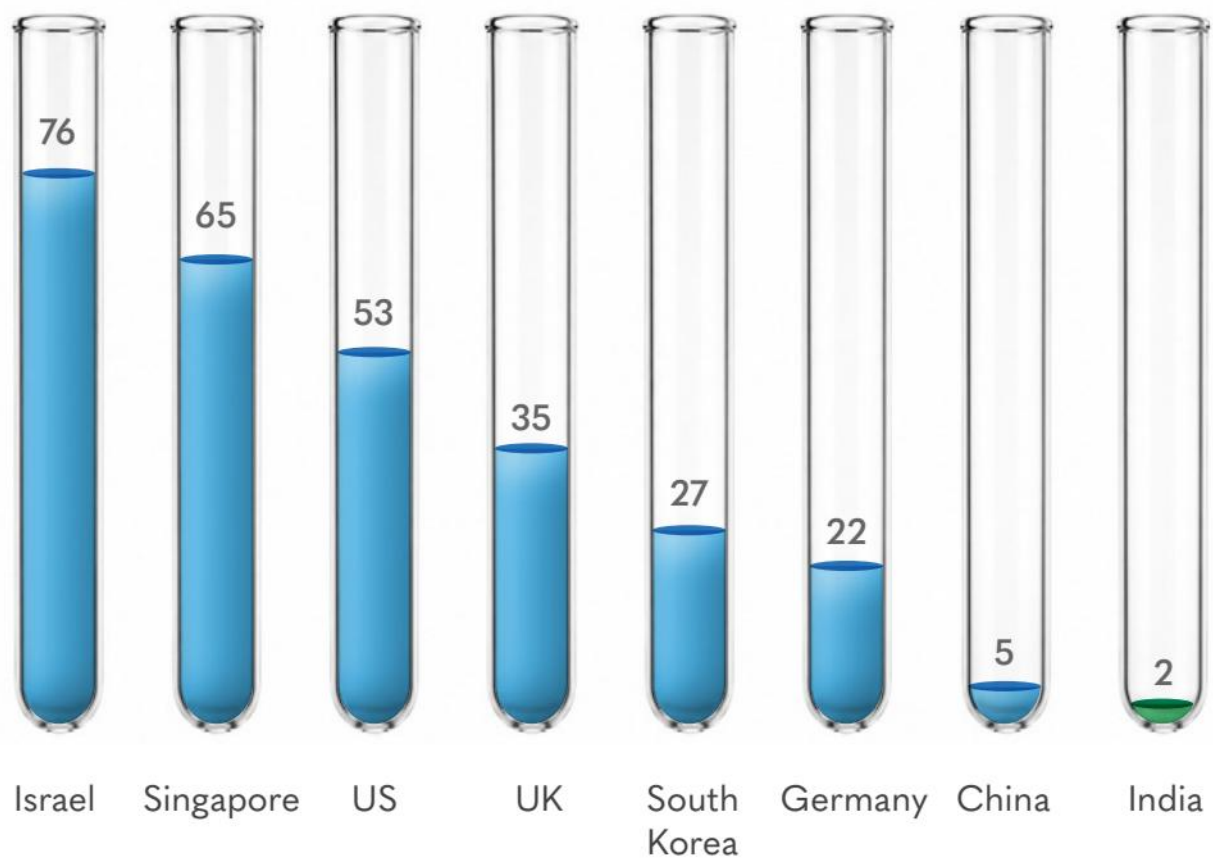


图表 2

企业通过多条路径构建竞争优势

印度公司正通过多种创新路径参与竞争：后期许可引进、先在印度验证再全球扩张、全球首创创新通过对外许可变现、学术衍生公司和纯生物技术平台。标志性交易包括Glenmark与艾伯维达成的7亿美元首付款许可协议，以及ImmunoACT与西普拉在非洲的合作——这些交易表明全球认可度正在提升。

印度最有机会胜出的领域集中在三个方向：成本颠覆式创新——重新设计先进疗法以实现可负担的大规模生产；基于印度特有生物学和数据的精准医疗方案，这类方案难以被复制；以及利用人才和成本效率的科学驱动型平台创新。



图表 3

结构性短板决定创新潜力能否兑现

结构性约束仍然显著。早期耐心资本获取有限——印度仅有约10-15%的不确定性研究机构具备深厚的制药或生物技术专业经验，而美国这一比例约为60%。从学术研究到临床应用的转化仍然薄弱。临床试验基础设施、监管能力和国内供应链的执行差距继续拖慢创新规模化。

未来五年将决定印度是成为全球创新原创者，还是停留在成熟的开发枢纽。条件已经具备，但结果尚未注定。